Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos

Autos nº 0848254-21.2024.8.12.0001

Classe: Tutela Cautelar Antecedente - Fornecimento de medicamentos

Requerente:Davyd Bernal de Quadros

Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul e outro

Sentença

Davyd Bernal de Quadros ajuizou **"Ação de Obrigação de Fazer para Fornecimetno de Medicamentos c/c Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente"**, a fim de que o MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE e o ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ambos qualificados, forneçam-lhe o tratamento medicamentoso prescrito. Alega que é portador de POLINEURRODÍCULOPATIA INFLAMATÓRIA DESMIELINIZANTE CRÔNICA, e que o tratamento é de alto custo, sendo necessária a utilização do medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA, 5g/100ml, enquanto for necessário, conforme especificação médica. Diante da necessidade do medicamento prescrito pelo médico que lhe acompanha, além da falta de condições financeiras em arcar com os custos do tratamento e pela desídia do requerido em fornecê-lo, requereu a concessão da tutela de urgência para que lhe seja disponibilizado o medicamento acima mencionado, conforme prescrição médica. Pediu, ao final, o julgamento procedente para confirmar a obrigação de fornecer o medicamento prescrito. Requereu a justiça gratuita e juntou documentos (fls. 12/37).

Natjus apresentou parecer às fls. 38/43.

Tutela provisória de urgência e gratuidade processual concedidas às fls. 47/52.

Citado, o Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contestação, na qual levantou preliminar incorreção do valor da causa, incompetência absoluta, indicando que a União deveria integrar o polo passivo, conforme Tema 793 oriundo do julgamento do RE 855.178 no âmbito do STF, IAC 14 do STJ e decisão proferida no âmbito do Tema 1234 do STF, e inépcia da inicial por pedido genérico. No mérito argumentou que apesar do medicamente estar padronizado no RENAME, sob o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), oferecida através de Protocolos Clínicos e Diretrizes- Terapêuticas (PCDTs), não tem indicação para a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINNE SIMOES DE SOUZA, liberado nos autos em 21/07/2025 às 19:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848254-21.2024.8.12.0001 e código d15zbrL0.

patologia da parte autora (polineurrodiculopatia inflamatória desmielinizante crônica), sendo imprescindível a comprovação da eficácia do tratamento. Afirma que o SUS oferece o procedimento de plasmaférese, em unidades hospitalares especializadas para tratamento da mencionada patologia e ressaltou o alto custo do tratamento e a limitação de recursos do Estado. Pediu o julgamento improcedente dos pedidos (fls. 58/74).

Em réplica, a requerente rebateu os argumentos das defesas, voltando às suas teses e pedidos (fls.81/88).

O Município de Campo Grande contestou às fls. 90/105, apresentando preliminar de incorreção do valor da causa, de incompetência do Juízo, No mérito sustentou a improcedência da ação, uma vez que não há comprovação da eficácia do medicamento para o caso clínico da autora, ainda que o princípio ativo esteja padronizado no RENAME (utilização *off label*).

Houve réplica às fls. 111/118.

Diante da fixação de requisitos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), quando da fixação da tese firmada no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), as partes foram intimadas a se manifestarem quanto ao preenchimento dos requisitos, e apresentaram manifestação às fls. 124/125, fls. 143/145 e f. 146.

Finalmente manifestaram desinteresse na produção de outros meios de prova (f. 154, f. 157 e f. 158).

É o relatório.

Decido:

Inicialmente, concernente à **preliminar de incompetência da Justiça Estadual** para julgar a lide, face a responsabilidade da União ao fornecimento de medicamento oncológico, deve ser rejeitada.

Neste aspecto, é necessário esclarecer que há posicionamento predominante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul a respeito da competência deste juízo para conhecer dos feitos relativos à saúde pública e da não inclusão da União no polo passivo da lide até que haja o julgamento definitivo do Tema 1234 pelo Superior Tribunal Federal.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES –

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINNE SIMOES DE SOUZA, liberado nos autos em 21/07/2025 às 19:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848254-21.2024.8.12.0001 e código d15zbrL0.

INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NÃO CABIMENTO – REJEITADAS – MÉRITO – DIREITO À SAÚDE – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO E A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – INOBSERVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NO RE N.º 1.366.243 (TEMA 1234/STF) – SEGURANÇA CONCEDIDA. O questionamento sobre qual é a parte legitimada para fornecer medicamento no caso concreto, conforme a legislação de regência, diz respeito ao exercício do controle de competência dos Juizados Especiais, porquanto a inclusão ou não da União no feito poderá levar o trâmite e consequente julgamento do processo à Justiça Federal, de modo que a competência para processar e julgar o presente Writ é do Tribunal de Justiça (Precedentes do STJ). Preliminar de incompetência rejeitada. O presente mandamus foi impetrado contra acórdão da 2.ª Turma Recursal Mista do Estado de Mato Grosso do Sul, o qual não é passível de impugnação por meio de recurso com efeito suspensivo próprio, de modo que é cabível o presente Writ. Preliminar de não cabimento rejeitada. As demandas relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema n.º 1234, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União Federal no polo passivo. Segurança concedida.(TJMS. Mandado de Segurança Cível n. 1401864-78.2023.8.12.0000, Turmas Recursais, 3ª Seção Cível, Relator (a): Des. Ary Raghiant Neto, j: 30/06/2023, p: 03/07/2023).

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NÃO CABIMENTO – REJEITADAS – MÉRITO – DIREITO À SAÚDE – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL QUE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINNE SIMOES DE SOUZA, liberado nos autos em 21/07/2025 às 19:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848254-21.2024.8.12.0001 e código d15zbrL0.

> *DETERMINOU A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO E A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – INOBSERVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NO RE N.º 1.366.243 (TEMA 1234/STF) – SEGURANÇA CONCEDIDA. O questionamento sobre qual é a parte legitimada para fornecer medicamento no caso concreto, conforme a legislação de regência, diz respeito ao exercício do controle de competência dos Juizados Especiais, porquanto a inclusão ou não da União no feito poderá levar o trâmite e consequente julgamento do processo à Justiça Federal, de modo que a competência para processar e julgar o presente Writ é do Tribunal de Justiça (Precedentes do STJ). Preliminar de incompetência rejeitada. O presente mandamus foi impetrado contra acórdão da 2.ª Turma Recursal Mista do Estado de Mato Grosso do Sul, o qual não é passível de impugnação por meio de recurso com efeito suspensivo próprio, de modo que é cabível o presente Writ. Preliminar de não cabimento rejeitada. As demandas relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema n.º 1234, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União Federal no polo passivo. Segurança concedida. (TJMS. Mandado de Segurança Cível n. 1401864-78.2023.8.12.0000, Turmas Recursais, 3ª Seção Cível, Relator (a): Des. Ary Raghiant Neto, j: 30/06/2023, p: 03/07/2023).*

Aliado a isso, no que toca à mais recente decisão, proferida pelo Min. Gilmar Mendes no RE 1.366.243/SC, só se autoriza a inclusão da União e a remessa do feito nos casos de medicamentos padronizados de responsabilidade dela, senão vejamos:

> *"(...) 5.1 nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINNE SIMOES DE SOUZA, liberado nos autos em 21/07/2025 às 19:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848254-21.2024.8.12.0001 e código d15zbrL0.

> *polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;*
>
> *5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (...)".*

No caso dos autos, ainda que o medicamento esteja incluído no RENAME, ou seja, disponibilizado pelo SUS, deve-se considerar a responsabilidade solidária dos entes públicos, nos termos do Tema 793 do STF, além do que a publicação do julgamento do Tema 234 pelo STF, que definiu as regras de competência, somente ocorreu em 11.10.2024. Assim, diante da modulação dos efeitos da indicada decisão, tais premissas somente são válidas para processos ajuizados após tal data, o que não é o caso deste feito.

Por tais razões, uma vez proposta a demanda, a despeito da solidariedade reconhecida no Tema 793 do STF, em tendo o requerente optado em ajuizar a ação perante a Justiça Estadual, o prosseguimento do feito neste Juízo é a medida que se impõe, ainda que por ora.

O mesmo se estende quanto ao pedido de responsabilização da União pelo fornecimento de medicamentos oncológicos no SUS, o qual de igual forma não merece prosperar.

Isto porque, no tocante à Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793), embora seja de conhecimento deste juízo a responsabilidade da União pelo financiamento oncológico e, considerando a solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde e tendo a parte autora ingressado com a ação em face do Estado de Mato Grosso do Sul, vislumbra-se ser cabível, por ora, o atendimento do pedido pelo requerido, cujas UNACON ou CACON, poderão solicitar o reembolso ao Ministério da Saúde. Rejeito, portanto, esta preliminar.

Acerca do **valor da causa**, acolho a preliminar levantada pelo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINNE SIMOES DE SOUZA, liberado nos autos em 21/07/2025 às 19:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848254-21.2024.8.12.0001 e código d15zbrL0.

requerido para corrigi-la, eis que se trata de ação em que se busca obrigação de fazer para que o requerido providencie tratamento medicamentoso através da rede pública de saúde, do modo que não há como se mensurar o proveito econômico por envolver direito constitucional à saúde.

Salienta-se que, embora seja possível mensurar o custo do medicamento através de orçamentos emitidos pela rede privada, o que a parte almeja não é o valor do procedimento em si, mas a condenação do requerido à obrigação de fornecer o tratamento pelo SUS.

Nesse sentido tem sido o entendimento atual do e. TJMS, embasado em entendimentos do STJ:

> *APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - VIA INADEQUADA - CIRURGIA NA COLUNA – PEDIDO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO requerido AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSTERGAÇÃO DA FIXAÇÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DEVIDA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC -* ***PRETENSÃO POSSUI VALOR INESTIMÁVEL - DECORRENTE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS*** *– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] II - A sentença não é ilíquida para fins de postergação da fixação dos honorários de sucumbência para a fase de liquidação. III -* ***Trata-se de ação de obrigação de fazer onde o autor pleiteia a condenação do Município ao custeio de procedimento cirúrgico do qual necessita e não tem condições financeiras de arcar, tendo como valor da causa o custo da cirurgia caso fosse realizada de forma particular, conforme se infere do orçamento apresentado****. IV -* ***Porém, malgrado tenha sido atribuído valor da causa com base no custo da cirurgia, é certo que a parte Autora não almejou o valor da prestação em si, mas sim a obrigação de fazer (de ser***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINNE SIMOES DE SOUZA, liberado nos autos em 21/07/2025 às 19:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848254-21.2024.8.12.0001 e código d15zbrL0.

> ***submetido a cirurgia), a qual possui valor inestimável, uma vez que decorre de direitos fundamentais****, sendo inaplicável o disposto no §§ 3ª e 4º, III, do art. 85 do CPC. Nesta senda, aplica-se, então, a regra contida no art. 85, § 8º do CPC, que prevê a fixação dos honorários de forma equitativa. V - Levando em consideração a média complexidade da causa, com pedido de realização de cirurgia, sendo inclusive realizada prova pericial, o trabalho desenvolvido pelo causídico, tempo de tramitação do processo (mais de três anos), tem-se como suficiente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). VI – Recurso conhecido e provido. (**TJMS**. Apelação / Remessa Necessária n. 0820341-40.2019.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 30/09/2022, p: 06/10/2022) (gn)*

Assim, nos termos do art. 292, II e § 3º, do CPC, retifico o valor atribuído à causa para **R$ 1.000,00** (mil reais) apenas para efeitos ficais, eis que o direito é inestimável.

Finalmente rejeito **a preliminar de inépcia da inicial**, pois o pedido é certo e determinado, sobre o qual foi possível a suficiente emissão de parecer pelo NAT com os documentos juntados, além do que a falta de documento necessário e eventual caráter genérico do pedido à comprovação dos fatos constitutivos alegados pelo autor são ônus que devem ser arcados por ele quando do julgamento de mérito.

Inicialmente, como as matérias ventiladas nos autos são unicamente de direito e aquelas de fato já se encontram sobejamente demonstradas pela farta prova documental anexada aos autos, a hipótese de julgamento antecipado da lide, presente no artigo 355, inc. I, CPC, restou configurada. Sendo assim, a dilação probatória afigura-se mesmo despicienda, cabendo ao juiz conhecer diretamente do pedido, exatamente como a legislação processual lhe autoriza.

Assinala-se que, de acordo com as regras ordinárias de distribuição dos ônus das provas previstas no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar os fatos constitutivos dos direitos que reclama em juízo, e ao réu, os fatos que alega em contraposição, sejam modificativos, impeditivos ou extintivos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINNE SIMOES DE SOUZA, liberado nos autos em 21/07/2025 às 19:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848254-21.2024.8.12.0001 e código d15zbrL0.

No **mérito**, verifica-se que o requerente busca que o requerido lhe forneça o medicamento *IMUNOGLOBULINA HUMANA, 5g/100ml*, diante da impossibilidade de custeá-lo.

O parecer do NAT, apresentado às fls. 38/44 é favorável ao atendimento dos pedidos autorais, ressaltando que apesar de estar registrado na ANVISA (f. 40), foi incorporado ao SUS (f. 43), todavia, para o tratamento de doença diferente da apresentada pela paciente. Isto é, no caso em tela se trata de um medicamento *off label*, de modo que, para a doença do requerente, os resultados ainda são incertos, o que, acrescido ao elevado custo para o seu fornecimento, torna inviável a concessão.

Assim, diante do alto custo do medicamento, da falta de evidência clínicas suficientes, pois baseada em apenas um ensaio clínico **não randomizado**, não há como conceder o medicamento à requerente, em observância ao Tema 06 do STF e a Súmula Vinculante nº 61. Vejamos o estudo colacionado à Nota Técnica do NAT:

> *As diretrizes da European Federation of Neurological Society/Peripheral Nerve Society (EFNS/PNS) fornecem recomendações sobre tratamentos de PIDC, com o objetivo de reduzir os sintomas e, se possível, manter a remissão a longo prazo. O tratamento com imunoglobulina intravenosa (IGIV) ou corticosteroides é recomendado em pacientes com incapacidade moderada a grave. Se a IGIV e os corticosteroides forem ineficazes, a plasmaférese deve ser considerada. Se a resposta for inadequada ou a dose de manutenção necessária for alta, tratamentos combinados de imunossupressores ou imunomoduladores devem ser considerados. Nenhuma recomendação é fornecida sobre o gerenciamento de longo prazo, devido à falta de evidências. Além disso, os tratamentos podem estar associados a eventos adversos (EAs) ou redução da independência do paciente. Por exemplo, os corticosteroides estão associados a desafios de tolerabilidade a longo prazo, enquanto a IVIG precisa ser administrada regularmente em um ambiente clínico ou em casa sob a supervisão de enfermeiras.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINNE SIMOES DE SOUZA, liberado nos autos em 21/07/2025 às 19:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848254-21.2024.8.12.0001 e código d15zbrL0.

O tratamento do PIDC é complicado por desafios no diagnóstico. A doença pode apresentar sintomas diferentes e existem pelo menos 15 conjuntos de critérios diagnósticos que descrevem o PIDC e suas formas variantes. A apresentação variável de PIDC e a má interpretação dos estudos de condução nervosa resultam em uma alta taxa de erros de diagnóstico. Isso pode resultar em tratamento inadequado, pois os pacientes com PIDC podem ser diagnosticados erroneamente com outras polineuropatias, como neuropatia por glicoproteína associada à antimielina (MAG) ou polineuropatia da síndrome POEMS (polineuropatia, organomegalia, endocrinopatia, proteína M e alterações cutâneas), que requerem tratamentos diferentes do PIDC.

Existem desafios significativos na caracterização do ônus da doença para doenças raras, como PIDC, e as evidências podem ser limitadas. Identificar e subsequentemente recrutar pacientes para estudos é um desafio; tamanhos de amostra baixos podem prejudicar a generalização e poder estatístico.

As publicações sobre os tratamentos atuais incluíram ensaios clínicos (n = 23, 60%), estudos do mundo real (n = 13, 31%), revisões de literatura (n = 3, 7%) e um estudo combinado do mundo real e clínico (n = 1, 2%). A maioria dos ensaios clínicos (incluindo o estudo combinado do mundo real e clínico) foram estudos comparativos, com um braço de placebo (n = 10, 38%) ou um comparador ativo (n = 9, 35%). Uma minoria de estudos do mundo real enfocou um único tratamento (n = 4, 31%); o restante relatou em tratamentos múltiplos (n = 9, 69%). Os tamanhos das amostras para os estudos do mundo real, que incluíram análises de bancos de dados e exames de pacientes, variaram de 13 a 432, enquanto os tamanhos das amostras de ensaios clínicos variaram de 27 a 265. Nenhuma diretriz de tratamento foi identificada.

Os estudos foram altamente heterogêneos em relação à

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINNE SIMOES DE SOUZA, liberado nos autos em 21/07/2025 às 19:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848254-21.2024.8.12.0001 e código d15zbrL0.

intervenção, comparador, ponto no tempo e metodologia. A definição de "resposta ao tratamento" variou entre os estudos e incluiu aumentos de pontuação predefinidos em escalas de resultados funcionais (por exemplo, escala de Rankin), avaliação do médico assistente e medição de força (por exemplo, força de preensão).

Embora muitos pacientes tenham respondido à terapia com corticosteroides (taxa de resposta de 48 a 83%, em nove estudos), preocupações de segurança foram associadas ao uso a longo prazo. EAs comuns incluíram hipertensão, diabetes mellitus de novo, glaucoma, depressão, aparência cushingoide e queixas gastrointestinais. Consequentemente, muitos pacientes em países de alta renda recebem IGIV, que tem eficácia semelhante e está associado a menos EAs.

IGIV geralmente alcançou altas taxas de resposta ao tratamento (taxa de resposta de 44-91%, em 11 estudos), em relação ao placebo. Onde foram relatados dados comparativos, IGIV aumentou a proporção de pacientes com PIDC que responderam ao tratamento, em relação aos comparadores, incluindo corticosteroides e plasmaférese. Markvardsen et al. 2013 relataram que durante a terapia IGIV de longo prazo, o acesso intravenoso pode se tornar difícil devido à obliteração das veias e pode necessitar de cateterização da veia jugular externa em alguns pacientes.

As imunoglobulinas subcutâneas (IGSC) fornecem uma via alternativa de administração que pode melhorar alguns dos desafios associados à administração intravenosa de imunoglobulinas. Três estudos relataram a estabilidade clínica de pacientes com PIDC após o início do IGSC, com todos os estudos constatando que a maioria dos pacientes estava clinicamente estável ou melhorada (83-100%; n = 13-245). O maior estudo sobre tratamento com IGSC (PATH, n = 172, controlado por placebo) encontrou a proporção de pacientes com recaída PIDC ou que foram retirados do estudo por

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINNE SIMOES DE SOUZA, liberado nos autos em 21/07/2025 às 19:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848254-21.2024.8.12.0001 e código d15zbrL0.

qualquer outro motivo que foi de 63% para pacientes no grupo placebo, 39% para pacientes no grupo IGSC de baixa dose, e 33% para pacientes recebendo altas doses de IGSC.

Estudos sobre dados de resultados relatados pelo paciente (PRO) do IGSC relataram predominantemente a facilidade de uso ou a preferência do paciente. Em Van Schaik et al. 2017, 88% (n = 172) dos pacientes relataram que aprender a técnica de administração IGSC foi fácil. Três estudos relataram a preferência do paciente, demonstrando que 53-88% dos pacientes preferiram IGSC a IGIV. As razões para preferir IGSC incluíram ganho de independência, facilidade de uso, maior flexibilidade durante a vida diária, desempenho muscular mais estável e efeitos colaterais mais leves, e que o tratamento economizou tempo em comparação com IGIV. Van Schaik et al. 2017 relatou que um estudo prospectivo aberto mostrou uma redução significativa na gravidade e frequência de dores de cabeça e náuseas após infusões IGSC em comparação com infusões IGIV. Cocito et al. 2018 relataram que o uso de IGSC foi associado a melhor qualidade de vida e menos EAs sistêmicos em comparação com IGIV em estudos observacionais.

A suplementação de IGIV com um imunossupressor concomitante pode ser uma estratégia eficaz para melhorar as taxas de resposta ou reduzir as dosagens de IGIV. Querol et al. 2013 relataram que a porcentagem de respondedores à terapia foi maior entre os pacientes que receberam tratamento imunossupressor concomitante do que aqueles que receberam apenas IGIV (71,4 versus 44,0%; OR 3,18). Mahdi-Rogers et al. 2009 mostrou que o metotrexato reduziu a dose semanal média de IGIV ou IGSC em 52% (n = 27) dos pacientes em comparação com uma redução de 44% (n = 32) no grupo placebo.

A troca de plasma pode fornecer uma terapia alternativa para pacientes que não respondem a IGIV e corticosteroides.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINNE SIMOES DE SOUZA, liberado nos autos em 21/07/2025 às 19:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848254-21.2024.8.12.0001 e código d15zbrL0.

Embora 48-81% dos pacientes em todos os estudos tenham respondido à troca de plasma, dados comparativos sugerem que menos pacientes atingem uma resposta à troca de plasma em comparação com IGIV. Em um estudo de 16 pacientes com PIDC, a plasmaférese foi associada à dificuldade de acesso às veias e déficit de fatores de coagulação sanguínea. No mesmo estudo, uma proporção maior de pacientes apresentou EAs com plasmaférese (25%) do que com corticosteroides (13%) ou IG PIDC (4%).

Publicações sobre o uso de imunomoduladores (fingolimode oral e interferon ß-1a intramuscular) para PIDC não indicaram melhora na eficácia em comparação com placebo.

Dados limitados estavam disponíveis sobre a capacidade de prever a resposta ao tratamento; apenas um estudo explorou a capacidade de prever a resposta ao tratamento entre critérios diagnósticos (critérios EFNS, AAN, INCAT e Saperstein). Os pacientes responderam ao tratamento com IGIV de forma semelhante (66-91%, n = 9-22), independentemente dos critérios diagnósticos usados, embora os critérios EFNS 2010 tenham sido os mais sensíveis para diagnóstico.

(Systematic literature review of burden of illness in chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP). Querol L, Crabtree M, Herepath M, et al. J Neurol. 2021 Oct;268(10):3706-3716) – grifo nosso

Tal conclusão contraria de forma direta um dos requisitos fixados no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)

Passemos à análise da Súmula Vinculante n. 61, que possui a seguinte redação:

Súmula vinculante nº 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINNE SIMOES DE SOUZA, liberado nos autos em 21/07/2025 às 19:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848254-21.2024.8.12.0001 e código d15zbrL0.

listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

Assim, a tese firmada no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) preleciona:

> *"1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja,* ***unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise****; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento."* - grifo nosso

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINNE SIMOES DE SOUZA, liberado nos autos em 21/07/2025 às 19:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848254-21.2024.8.12.0001 e código d15zbrL0.

Necessária, portanto, a análise dos requisitos definidos pelo STF para a concessão do medicamento pretendido, pois, a partir de sua publicação passou a gerar efeitos:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1.234 da repercussão geral – comprovada conforme documento juntado às fls. 30 e fls. 124/125.

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011 – Verifico que o medicamento foi analisado pela Conitec, todavia, para o tratamento de outras doenças.

Não se evidencia, portanto, a ilegalidade ou demora na falta de padronização junto ao SUS. *Requisito não preenchido.*

No entanto, diante da presumida gravidade do caso, passo à análise dos demais requisitos.

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas – ainda que o parecer do NAT indique protocolo do SUS para o tratamento da autora, o laudo médico de fls. 21/22, emitido pelo profissional que acompanha o autor, ressalta a importância do novo protocolo recomendado.

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise – de acordo com a Nota Técnica do NAT, "*A Imunoglobulina Humana está padronizada na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2022), sob o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), oferecida através de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs), para doença diferente do paciente que corresponde a polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica (PIDC)*" - f. 42.

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado – conforme laudo médico (fls. 21/22).

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINNE SIMOES DE SOUZA, liberado nos autos em 21/07/2025 às 19:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848254-21.2024.8.12.0001 e código d15zbrL0.

medicamento – comprovada uma vez que deferida em favor dela a gratuidade processual, nos termos da decisão de fls. 47/52, e no documento de f. 126, do que se presume a necessidade de custeio do tratamento pelo Poder Público.

Portanto, **não estão presentes** os requisitos autorizadores à concessão dos medicamentos.

Na tese fixada no Tema 6 do STF, houve determinação expressa de observância dos requisitos pelos magistrados, sob pena de nulidade de decisão proferida. Vejamos:

> *"3. Sob pena de **nulidade da decisão judicial**, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao **apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente**: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS".*

Pelo exposto, a ação deve ser julgada **improcedente**, por força das fundamentações acima delineadas e considerando a necessidade de pautar as demandas de saúde na medicina baseada em evidência.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINNE SIMOES DE SOUZA, liberado nos autos em 21/07/2025 às 19:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848254-21.2024.8.12.0001 e código d15zbrL0.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, revogo a tutela de urgência e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais propostos por Davyd Bernal de Quadros em face do Estado de Mato Grosso do Sul e do Município de Campo Grande.

Condeno a autora ao pagamento da custas e despesas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$ 2.000 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Por fim, ante os princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade, em caso de eventuais apelações interpostas e, considerando que não há mais juízo de admissibilidade por parte do primeiro grau, caberá ao Cartório, mediante ato ordinatório, abrir vista à parte contrária para oferecimento das contrarrazões. Na sequência, deverá remeter os autos ao E. Tribunal de Justiça. Ressalva-se, entretanto, a hipótese de embargos de declaração, quando os autos deverão vir conclusos.

Sem reexame necessário, nos termos do artigo 496, §3º do CPC.

Certificado o decurso do prazo para interposição de recurso, remetam-se ao e. Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Oportunamente, arquive-se.

Campo Grande, data da assinatura digital.

Paulinne Simões de Souza

Juíza de Direito

(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINNE SIMOES DE SOUZA, liberado nos autos em 21/07/2025 às 19:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0848254-21.2024.8.12.0001 e código d15zbrL0.